EDN · RÉVISION MÉDICALE

Dermatologie

Révision médicale complète · 15 chapitres · 61 illustrations

EDN

Informations

EDN — Dermatologie

© 2026 EDN. Tous droits réservés.

Document de révision destiné à l'usage personnel des étudiants en médecine. Ce document n'est pas un avis médical et ne remplace aucun enseignement universitaire ni le référentiel officiel.

Source : documentation de révision EDN mise à disposition publiquement.

Langue : français. Format : EPUB 3.

Les tableaux de la source ont été convertis en texte : le libellé de chaque ligne est repris tel quel, et chaque colonne est nommée. Aucune donnée n'a été ajoutée, supprimée ni réordonnée.

Navigation : la table des matières de la liseuse donne accès à chaque chapitre. Les sections encadrées sont repliables d'un toucher.

Sommaire

Références

1 Dermatoses faciales (111)

2 Dermatoses bulleuses auto-immunes (112)

3 Psoriasis (117)

4 Urticaire, Dermatite Atopique, Eczéma de contact (187)

5 Toxidermies (115) (325)

6 Dermocorticoïdes (330)

7 Hémangiomes et Malformations vasculaires (113)

8 Exanthème et érythrodermie (114)

9 Prurit (116)

10 Grosse jambe rouge aiguë (350)

11 Infections cutanéo-muqueuses et des phanères (155)

12 Infections sexuellement transmissibles (IST) (162)

13 Tumeurs cutanées (302)

PARTIE 1 — FICHES TRANSVERSALES

14 Fiches transversales

Références

Dermatologie FACILE aux EDN +++

> *Revêtement cutané : cedef.org*

> *CEDEF - 2ème cycle DFASM*

> *Pour des images en plus : Images A-Z | DermNet*

Dermatoses faciales (111)

Acné

Définition. Dermatose inflammatoire chronique du follicule pilo-sébacé

Terrain. Plutôt chez l'adolescent

Physiopathologie de l'acné

Séborrhée

Séborrhée = augmentation de la production de sébum par la glande sébacée

- Physiologie : testostérone libre → transformée dans les cellules sébacées par la 5α-réductase de type 1 en dihydrotestostérone qui se fixe sur récepteurs des androgènes situés sur le sébocyte → déclenche et entretient la sécrétion du sébum
- Acné : Androgènes circulants sont présent à des **taux normaux**, mais l'acnée résulte d'une **sensibilité particulière des récepteurs androgéniques** présents sur le sébocytes et sur les kératinocytes (= hyperandrogénie périphérique)

Kératinisation infundibulaire du follicule pilo-sébacé

Formation du comédon (= accumulation de sébum, kératinocytes et mélanine qui remplissent le pore de la peau) qui est dûe à :

- Hyperprolifération des kératinocytes du follicule pilo-sébacée
- Anomalies de leur différenciation qui **empêchent une élimination normale des kératinocytes** de l'épithélium du canal infundibulaire

Comédons = lésions élémentaires rétentionnelles

Microbes

Inflammation

Acné n'est pas une maladie infectieuse mais une maladie inflammatoire ⚠️

Flore anaérobie des follicules pilo-sébacés dominée par bactérie Gram + (**Cutibacterium acnes** *anciennement Propionibacterium acnes*) :

- Propionibacterium acnes sécrète de nombreux **facteurs induisant l'inflammation du follicule pilo-sébacé**
- Il existe différentes souches de Cutibacterium acnes qui ont un **pouvoir inflammatoire différent**
  - donc les souches sur un **sujet sain** sont **différentes** des souches de la peau d'un **sujet acnéique**

Atteinte cutanée

Acné

Rosacée

Dermatite séborrhéique

Germe

Propionibacterium acnes

Demodex folliculorum